

УДК: 618.19-006.0:615.277

С.Е.Есентаева, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, А.К.Туманова, Н.А.Омарбаева, К.К.Смагулова,
Н.Ж.Шалкарбаева, З.Т.Ильянова, А.Я.Тогузбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Оценка эффективности схемы паклитаксел+доксорубицин в 1 и 2 линии химиотерапии местнораспространенных и диссеминированных форм рака молочной железы

Аннотация Химиотерапия паклитаксела с доксорубицином является эффективной схемой при диссеминированных и при местнораспространенных формах РМЖ, в качестве 1 и 2 линии. Данная схема ХТ позволила получить общий терапевтический эффект в 70,6% и 75,5% случаев соответственно. Дозолимитирующей токсичностью явилось нейтропения и нейротоксичность, однако эти побочные эффекты не привели к прекращению лечения ни в одном случае.

Ключевые слова: рак молочной железы, местнораспространенная и диссеминированная форма, химиотерапия.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний среди женщин. В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 3000 больных раком молочной железы из которых умирают более 1380 женщин. В частности, в 2011 году зарегистрировано 3525 случаев рака молочной железы, что составило 11,6 на 100000 населения. Летальность на 1 году жизни составляет 8%, а 5-летняя выживаемость - 52,9%. (Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. и др., 2012).

В 55,6% случаях при первичном обращении пациенток выявляется местно-распространенная форма РМЖ, и лечение таких пациенток начинают с химиотерапии, которая у большинства пациентов преследует три основные цели: увеличить предпосылки для выполнения органосохраняющего хирургического вмешательства, определить ответ на проводимое лечение и обеспечить длительную безрецидивную выживаемость (Переводчикова Н.И., 2010).

На вопрос, какие схемы лекарственной терапии эффективны в неoadъювантном режиме, в современной литературе нет однозначного ответа. Большинство исследований носит поисковый характер и посвящены оценке либо новых препаратов, либо ранее применявшихся во 2 линии. (Максимов И.В., Высоцкая В.Д., 2008)

Современная химиотерапия, включающая антрациклины превосходит режимы CMF. За последние 10 лет наряду с антрациклинами, таксаны прочно заняли лидирующие позиции в лечении как ранних, так и диссеминированных форм РМЖ. Консервативное лечение больных диссеминированным РМЖ является одной из наиболее трудных и актуальных проблем клинической онкологии. Современная химиотерапия, не

излечивая больных метастатическим РМЖ, позволяет получить выраженный клинический эффект более чем у 60% больных, продлевая безрецидивный период. Медиана выживаемости больных метастатическим РМЖ за последние 10 лет увеличилась с 18-24 мес до 24-36 мес, около 5% больных живут более 5 и даже 10 лет (Переводчикова Н.И., 2004,). Основным методом терапии диссеминированной РМЖ - лекарственное лечение. К полной ремиссии лекарственная терапия может привести только у 15% больных. Лишь некоторые из этих пациентов имеют шанс прожить 5 лет. У остальных больных полная ремиссия улучшает качество жизни и продлевает медиану выживаемости до 3 лет (Орлова Р.В., Моисеенко В.М., 2000). Химиотерапия при диссеминированном раке молочной железы применяется уже более 40 лет. За этот период около 50 препаратов стали доступными для практического использования. При этом 5 цитостатиков (доксорубицин, доцетаксел, эпирубицин, паклитаксел, винорельбин) позволяют получить лечебный эффект более чем у 50% пациенток. Эффективность остальных препаратов колеблется от 15 до 30%. Но, однако, средняя продолжительность жизни пациентов увеличилась только на несколько месяцев и данная форма заболевания по-прежнему остается неизлечимой. Более того, до настоящего времени нет общепринятых стандартов лечения этой патологии (Гарин А.М. 1998). Поэтому в практической деятельности по-прежнему в качестве I и II линий химиотерапии рекомендуются схемы с антрациклиновыми антибиотиками (AC, CAF), комбинации их с таксанами или CMF у пациенток, которые в силу имеющейся сопутствующей патологии не могут получить другие варианты терапии. Вместе с тем, постоянно ведется поиск новых более эффективных подходов к лечению, который осуществляется в трех направлениях. Прежде всего, это выявление новых комбинаций и режимов хорошо известных противоопухолевых. Большое внимание уделяется разработке новых эффективных цитостатиков (капецитабин и др.) и таргетных препаратов (трастузумаб, авастин), чтобы индивидуализировать лечение на основе молекулярных маркеров (HER-2, ER/PR, p53) (Deissler H. et al., 2003).

Целью нашего исследования

явилась оценка эффективности схемы паклитаксел+доксорубицин в 1 и 2 линии химиотерапии местно-распространенных и диссеминированных форм

рака молочной железы.

Материалы и методы исследования

В настоящем исследовании включена 61 больная раком молочной железы, разделенная на 3 группы. В I группу вошли 17 больных с диссеминированными формами РМЖ, из них 3 больных были с первично диссеминированным РМЖ, а 14 больных – повторные с метастатическим процессом в различные органы после проведенного комплексного лечения по поводу РМЖ. В отдельные группы (II, III группы) вошли 44 больных с местнораспространенными формами РМЖ, из них контрольную

составили 24 пациентки. Возраст варьировал от 36 до 68 года, средний возраст составил 52 лет.

Распределение больных по TNM:

- первичные больные с диссеминированными процессами I группа (3): T3N1M1 – 3.

- больные, поступившие с диссеминацией процесса после ранее проведенного комплексного или комбинированного лечения I группа (14): T2-3N1-M0-11, T4N1-2M0 – 3 больных.

- больные с местнораспространенными формами РМЖ-II группа (20)-T2N1M0-14, T3-4N1-2M0 – 6 больных.

- больные с местнораспространенными формами РМЖ-III группа (24)-T2N1M0-18, T3-4N1-2M0 – 6 больных.

Характеристика первично поступивших больных с распространенными формами РМЖ по локальному статусу(3): узловая форма - 1, язвенная форма - 2.

Характеристика больных с местно-распространенными формами- по локальному статусу: II группа (20) - узловая форма – 16, отечно-инфильтративная -4.

III контрольная группа (24) - узловая форма – 22, отечно-инфильтративная форма – 2 пациентки.

Основная гистологическая форма (81,9%) была представлена инфильтрирующей протоковой карциномой.

Все больные с диссеминированными формами РМЖ имели метастазы в различные органы: метастазы в лимфоузлы регионарных зон – у 3 больных, метастазы в легких и плевру у 3 больных. Метастазы в печень – у 3, сочетанное поражение легких и печени – у 4 больных. Сочетанное поражение лимфоузлов средостения, легких, костей скелета и печени – у 4 больных.

Схемы химиотерапии:

- I группа: - паклитаксел 175мг/м² 1 день, доксорубин 50 мг/м² в\в (или эпирубин 60 мг/м²) 1 день – 2-4 курса - 17 больных. После оценки результатов лечения у больных с частичной и полной регрессией опухоли больным проводилось дополнительно еще 2 курса химиотерапии в указанном режиме. Больные со стабилизацией процесса переводились на 2 линию химиотерапии: таксотер 75 мг/м² -1 день +карбоплатин 450-600 мг в\в\ в 1 день.

- II группа -паклитаксел 175мг/м² 1 день, доксорубин 50 мг/м² в\в (или эпирубин 60 мг/м²)- 1 день - получили 20 пациенток с местно распространенными формами РМЖ.

- III группа – контрольная: доксорубин -50мг/м² 1- день, циклофосфан 500мг/м² 1 день АС – 24 больных.

Эффективность лечения оценивалась после 4 курсов

химиотерапии. При развитии резистентности опухоли к цитостатикам и прогрессировании процесса больные переводились на очередную линию химиотерапии (таксотер+ карбоплатин, таксотер+ навельбин).

В случае выраженности побочных эффектов (гематологической и не гематологической токсичности) проводили коррекцию доз химиопрепаратов и / или увеличивали интервалы между курсами. Лечение у больных диссеминированными формами РМЖ продолжали до прогрессирования болезни или возникновения токсичности, препятствующей дальнейшему лечению.

Таблица 1 – Оценка эффективности химиотерапии у больных РМЖ

Схема ПХТ	Кол-во больных	Объективный эффект (>50%)			
		Полная регрессия	Регрессия более 50%	Стабилизация менее 50%	Прогрессирование
I. паклитаксел+ Доксорубин (мРМЖ)	17	-	12 (70,6±11,0%)	4 (23,5±10,3%)	1 (5,9±5,7%)
II. паклитаксел +доксорубин	20	1 (5,0±4,8%)	14 (70±10,2%)	5 (25±9,7%)	-
III.АС(доксорубин +циклофосфан)	24	-	18 (75,1±8,8%)	5 (20,8±8,3%)	1(4,1±4,04%)

Результаты

Лечебный эффект оценивался по критериям комитета экспертов ВОЗ (критерии эффекта по шкале ВОЗ). Общая характеристика побочных эффектов и факторов риска при химиотерапии оценивались по шкале токсичности (CommonToxicityCriteria NCLC).

Иммуногистохимические исследования проведены у 60 больных (или при настоящем или предыдущих поступлениях).

Оценка эффективности лечения после проведения 4 курсов химиотерапии в 1 группе показала, что общий объективный эффект достигнут у 12(70,6%) из 17 пациенток у остальных 4(23,5%) – стабилизация процесса с положительной динамикой (менее 50%), прогрессирование- в 1(5,9%) случае, причем у 2 больных, с язвенно-некротической формой рака молочной железы, отмечено уменьшение язвенного образования, стягивание краев раневой поверхности. У 2 больных отмечалась стабилизация процесса со сроком 4,5 месяца, после чего больная была переведена на другую линию химиотерапии (таксотер+ карбоплатин).

Оценка эффективности лечения после проведения 4 курсов химиотерапии показала, что во II группе общий объективный эффект достигнут у 15(75%) из 20 пациенток, из них полная регрессия-1(5%), регрессия более 50%-14(75%). У остальных 5(25%) – стабилизация процесса с положительной динамикой (менее 50%).

Во III группе у 18(75,1%) из 24 отмечался объективный эффект, регрессия более 50%- у 18(75,1%) больных. У остальных 5(20,8%) – стабилизация процесса с положительной динамикой (менее 50%), в 1 случае (4,1%) наступило прогрессирование процесса на фоне лечения.

Побочные эффекты изученных комбинации оценены из расчета проведенных курсов химиотерапии. Гематологическая токсичность в виде нейтропении была отмечена у 40(58.8%) , 30 (37.2%), 17(17.7%)

Таблица 2 - Оценка токсических эффектов у больных РМЖ

Побочные эффекты	Всего (из числа проведенных курсов)			3-я степень			4-я степень		
	I группа - 68	II группа - 80	III группа - 96	I	II	III	I	II	III
Анемия	19 (28%)	24 (30%)	12 (12.5%)	3 (4.4%)	4 (5,0%)	-	-		
Нейтро-пения	40 (58.8%)	30 (37.2%)	17 (17.7%)	7 (10.2%)	8 (10%)	5 (5.2%)	2 (2.9%)	1 (1.2%)	
Тромбоцитопения	7 (10.2%)	5 (4%)	5 (5.2%)	-	-	-	-		
Тошнота с эпизодами рвоты	49 (72%)	52 (65%)	48 (50%)	5 (7.4%)	2 (2.5%)	-	-		
Диарея	20 (29.4%)	28 (35%)	19 (19.8%)	6 (8.8%)	-	-	-		
Мукозит	6 (8.8 %)	12 (9.6%)	5 (5.2%)	-	-	2 (2.08%)	-		
Токсиче-ский гепатит	5 (7.4%)	4 (5%)	3 (3.1%)	-	-	-	-		
Нейроток-сичность	51 (75%)	64 (80%)	7 (7.3%)	2 (2.9%)	-	-	-		

Таблица 3 – Виды проведенных оперативных вмешательств во II группе

Стадии	Кол-во больных	Виды операции					
		ШСРМЖ с ЛД-24		РМЭ-17		РМЭ с имплантом-3	
		II	III	II	III	II	III
IIВ(T2N1M0)узловые формы	30 (68,2%)	10 (33,3%)	12 (40%)	2 (6,6%)	3 (10%)	3 (10%)	-
IIIВ(T3N1M0)узловая форма	8(18,2%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)	5 (62,5%)	-	-
IIIВ(T4N1M0) отечно-инфильтративные формы	6 (13,6%)	-	-	4 (66,7%)	2 (33,3%)	-	-
Всего	44 (100%)	11 (25%)	13 (29,5%)	7 (15,9%)	10 (22,7%)	3 (6,8%)	

Примечание* - ШСРМЖ с ЛД- широкая секторальная резекция молочной железы с лимфодиссекцией.

соответственно представленным группам, причем 4 степени нейтропении- у единичных больных. Анемия встречалась 1 в 9(28%), 24 (30%) и 12(12.5%) соответственно, тошнота с эпизодами рвоты, диарея наблюдались в одинаковом количестве наблюдений во всех группах, однако у пациентов, получающих паклитаксел эти побочные явления отмечались чаще. Нейротоксичность в основном наблюдалась у больных I и II групп, в то время, как у больных, получивших схему АС этот токсический эффект наблюдался гораздо реже. Всем больным с токсичностью проводилось специальная сопроводительная терапия.

Все пациенты II и III групп(44) после 4 курсов НАПХТ подверглись оперативному лечению.

Как видно из представленной таблицы-3 ШСРМЖ проведена 24 больным, РМЭ-17, подкожная мастэктомия с эндопротезированием выполнено 3 пациентам.

Проведение неоадьювантных курсов химиотерапии позволило выполнить органосохранные операции в обеих группах больных примерно в одинаковых случаях наблюдений, однако реконструктивную операцию удалось провести лишь у больных II группы.

В послеоперационном периоде изучался терапевтический патоморфоз опухоли. Как показано на рисунке 1- патоморфоз 4 степени был более выражен у больных II группы.

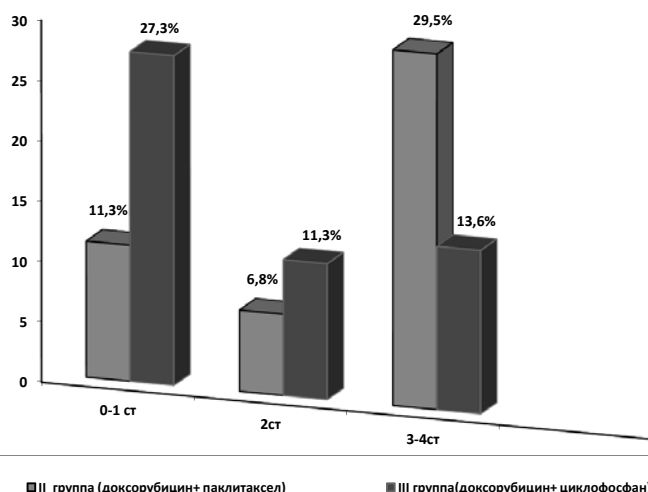


Рисунок 1- показатели патоморфоза клеток опухоли в зависимости от применяемых схем химиотерапии

Заключение

Комбинированная химиотерапия паклитаксела с доксорубицином является эффективной схемой как при

диссеминированных, так и при местно распространенных формах РМЖ, как в качестве 1 и 2 линии. Данная схема химиотерапии позволила получить общий терапевтический эффект в 70,6% и 75,5% случаев соответственно. Дозолимитирующей токсичностью явилось нейтропения и нейротоксичность, однако эти побочные эффекты не привели к прекращению лечения ни в одном случае.

Применение паклитаксела с доксорубицином в неоадъювантном режиме дало возможность провести органосохраняющие операции у 13 (65%) из 20 больных, из них в 3 случаях - реконструктивно-пластические. Изучение патоморфоза послеоперационного материала показало, что степень повреждения опухолевых клеток было более выражена при проведении химиотерапии паклитаксела с доксорубицином, чем при АС. Следующим этапом наших исследований планируется изучение общей и безрецидивной выживаемости больных, получающих лечение по изучаемым схемам.

Список литературы

- 1 Нургазиев К.Ш., Талаева Ш.Ж. и др. Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных заболеваний. Злокачественные новообразования молочной железы. - Алматы, 2012. - С. 258-274.
- 2 Руководство по химиотерапии /под редакцией Переводчиковой Н.И.-М., 2010.
- 3 Трапезников Н.Н., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ: Стат. сб. - М., 2001. - 72 с.
- 4 Семглазов В.Ф., Семглазов В.В., Клетсель А.Е. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // Мат. II международная ежегодной конф.: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы. - СПб, 2005. - С.78-84. 171.
- 5 Hamada N., Ogawa Y., Nishioka A. et al. Primary toremifene treatment for elderly postmenopausal women with breast cancer// Oncol. Rep. - 2004. - N 2 - P.365-370.
- 6 М.И.Давыдов, Е.М.Аксель. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2000г: Стат. сб. - М., 2002.
- 7 Гарин А.М. Сложные ситуации, трудные и спорные вопросы ведения и лечения больных раком молочной железы / Новое в терапии рака молочной железы /Под ред. Н.И. Переводчиковой. - М, 1998. - С. 67-76.
- 8 Моисеенко В.М. Современная химиотерапия диссеминированного рака молочной железы // Мат. III Российской онкологической конф. - СПб, 1999. - С.74.
- 9 Colleoni N. Litmanjastiglione A., Gertsch V. et al. International Breast Cancer study Group. Duration of neoadjuvant chemotherapy for breast cancer A a join analysis of two randomised trials investigation three versus six courses of CMF/Br. J. Cancer.- 2002.- Vol.86, N11.-H.1705-
- 10 Моисеенко В.М. Принципы лекарственного лечения / больных диссеминированным раком молочной железы // Практическая онкология. - 2000. - № 2 - С.19-21.
- 11 Fisher E.R., Wang J., Bryant J. et al. Pathobiology of preoperative chemotherapy findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel (NSABP) protocol B-18 //Cancer.- 2002.-Vol.95.-N4.-P.681-95.

Тұжырым

С.Е.Есентаева, Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, А.К.Туманова, К.К.Смагулова, Н.Ж.Шалкарбаева, З.Т.Ильянова, А.А.Тогузбаева, Н.А.Омарбаева

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Жергілікті жайылған және диссеминирленген сүт безі қатерлі ісігі кезіндегі 1 және 2-ші сызба химиотерапияның паклитаксел+доксорубицин кестесі бойынша емінің нәтижесін бағалау

Жергілікті жайылған және диссеминирленген сүт безі қатерлі ісігі кезінде қолданылатын паклитаксел+доксорубицин, тиімді химиотерапиялық сызба болып табылады. Бұл химиотерпия сызбасы диссеминирленген сүт безі қатерлі ісігінде жалпы емдік эффект – 70,6%, ал жергілікті жайылған сүт безі қатерлі ісігінде жалпы емдік эффект – 75,5%. Бұл ем кезінде токсикалық әсер ретінде нейтропения және нейротоксикалық әсер болды, екі топ ауруларды емдеу жағдайында да емдік курс тоқтатылған жоқ.

Паклитаксел мен доксорубицинді адъювантты емес режимінде қолдану 20 науқастарда 13де мүше сақтау отасында көптеген мүмкіндік берді, соның 3уі реконструктивті –пластикалық. Доксорубицин паклитакселмен ХТ жүргізгеннен кейін отадан кейінгі патоморфозда зақымдалған ісік жасушалары айқындау болған, АС препаратынан қарағанда.

Келесі біздің зерттеуіміз жалпы және рецидивсіз өтетін сызба бойынша ем алып жатқан науқастарда жүргізіледі.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, химиотерапия, жергілікті таралған және диссеминирленген түрі.

SUMMARY

Yesentayeva S.E., Talaeva S.Z., Chichua N.A., Tumanova A.K., Omarbaeva N.A., Smagulova K.K., Shalkarbayeva N.J., Ilyanova Z.T., Toguzbaev A.Y.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Evaluation of the effectiveness of paclitaxel + doxorubicin in 1 and 2-line chemotherapy for locally advanced and disseminated forms of breast cancer

The combination of paclitaxel with doxorubicin is an effective scheme at advanced and in locally advanced forms of breast cancer, as both 1 and 2 lines of chemotherapy. This scheme allowed for chemotherapy overall therapeutic effect in 70.6% and 75.5%, respectively. Neutropenia was the dose-limiting toxicity and neurotoxicity, however, these side effects did not lead to discontinuation of treatment in any case.

The use of paclitaxel with doxorubicin in the neoadjuvant provided opportunities for breast conserving surgery in 13 (65%) of 20 patients, of which 3 cases, reconstructive plastic. While investigating postoperative material pCR (pathologic cancer regression) showed that the degree of tumor cell damage was more pronounced in chemotherapy with paclitaxel + doxorubicin than it in AC. The next stage of our research is planned to study the overall and disease-free survival.

Keywords: breast cancer, chemotherapy, locally advanced and disseminated forms